Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de São Sebastião do Caí

Rua São Lourenço, 1113 - Bairro: Centro - CEP: 95760000 - Fone: (51)3098-5795 - Email: frsaoscai1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5006179-24.2022.8.21.0068/RS

AUTOR: FATIMA TERESINHA FLORES

RÉU: UNIMED VALE DO CAI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

I - Relatório

FATIMA TERESINHA FLORES ajuizou ação cominatória em face de **UNIMED VALE DO CAÍ/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, ambas devidamente qualificadas nos autos. Narrou que contratou plano de saúde da ré e que sempre honrou com as mensalidades. Referiu que é portadora de telangiectasia hemorrágica hereditária, síndrome rara conhecida também como Síndrome de Rendu-Osler-Weber, além das comorbidades que possui, como anemia, hipertensão arterial pulmonar, obesidade mórbida e bronquite aguda e, para tratamento da doença, lhe foi receitado, com urgência, o uso do fármaco "Bevacizumabe". Relatou que requisitou autorização para o tratamento, o que foi negado pela ré, sob o fundamento: "NÃO AUTORIZADO, desfavorável. Patologia não prevista em roll e uso offlabel de medicação, FAC 467047". Teceu considerações acerca do seu direito. Requereu, já em sede de tutela de urgência, fosse determinado o fornecimento do medicamento necessário ao tratamento prescrito. Subsidiariamente, postulou o pagamento ou ressarcimento de valores para aquisição particular dos fármacos. Juntou documentos (evento 1).

Foi deferido o pedido de tutela de urgência (evento 3).

Citada, a requerida apresentou contestação sustentando a impossibilidade de custear medicamento sem embasamento científico para o caso apresentado (*off label*). Discorreu sobre sua ilegitimidade passiva, alegando que a autora mantém contrato com a UNIMED PELOTAS (Evento 12, CONT4).

A UNIMED PELOTAS compareceu espontaneamente nos autos (Evento 16). Colacionou entendimento jurisprudencial sobre o tema, especificamente acerca do rol da ANS. Referiu a impossibilidade de ampliação da cobertura contratual, mencionando que o plano de saúde não pode responder por todas as mazelas da autora. Requereu a revogação da tutela e a improcedência.

Houve réplica ao evento 24.

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva da **UNIMED VALE DO CAÍ** (evento 24) e, após oposição de embargos ao evento 28, foi tornada sem efeito a decisão (evento 37). Na mesma decisão, as partes foram intimadas sobre o interesse na produção de provas, ocasião em que foi indeferido o pedido formulado (eventos 43 e 45).

Vieram conclusos para julgamento.

É o sucinto relatório.

Passo a fundamentar.

II - Fundamentação

Estão presentes, inicialmente, as denominadas condições da ação, bem como os pressupostos necessários à constituição válida e regular do processo, motivo pelo qual inexiste óbice à apreciação do mérito.

No caso, trata-se de relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90 (arts. 2º e 3º), consoante Súmula 608, do STJ "“*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*”.

Segundo consta na inicial, a requerente é portadora de telangiectasia hemorrágica hereditária, síndrome rara conhecida também como Síndrome de Rendu-Osler-Weber, além das comorbidades que possui, como anemia, hipertensão arterial pulmonar, obesidade mórbida e bronquite aguda e, para tratamento da doença, lhe foi receitado, com urgência, o uso do fármaco "Bevacizumabe. Além disso, referiu a *expert* que a não utilização dos medicamentos causaria risco de evolução rápida da doença.

Os exames médicos demonstram a enfermidade (Evento 1, EXMMED6), assim como os laudos médicos indicam o tratamento (Evento 1, ATESTMED8 e Evento 1, RECEIT7).

A fundamentação da ré tem como base o fato do medicamento não estar listado na Diretriz de Utilização elaborada pela Agência Nacional de Saúde.

Com efeito, como corolário lógico da submissão dos contratos que envolvem assistência à saúde (Lei nº 9.656/98) ao Código de Defesa do Consumidor, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser efetuada em favor da parte mais vulnerável na relação, sendo nulas, de pleno direito, aquelas que forem incompatíveis com a boa-fé processual, bem como as que se mostrarem extremamente onerosas ao consumidor.

Sobre o tema, dispõem os artigos 47 do CDC e 422 do Código Civil Brasileiro, *in verbis:*

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Mais a mais, conquanto cediço que é possível que a contratualidade havida entre as partes excetue determinados tratamentos, nos moldes do artigo 10 da Resolução Normativa nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde, que traz um rol de procedimentos que autoriza a negativa do tratamento por parte da operadora por ausência de previsão em norma regulamentadora, tais exclusões não podem - e não devem - ocorrer quando constatado que a fornecedora do plano de saúde assumiu a responsabilidade pela cobertura da enfermidade que agride o consumidor.

No bojo, não cabe à operadora definir quais os tratamentos que o consumidor deve se submeter para a luta contra a doença, sendo esta competência exclusiva do profissional de saúde que prescreve o procedimento mais adequado ao enfermo, mostrando-se inapropriada a intervenção da demandada em virtude de eventual perda econômica que possa vir a ter com o custeio do tratamento.

Aliás, se assim não fosse, frustraria criteriosamente a função social do contrato, que não atingiria a sua finalidade.

Nesse sentido, a propósito, verifico ser este o mesmo entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o qual faço a saber pelas ementas colacionadas:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO E INSUMOS. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDA. DANOS MORAIS OCORRENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o ressarcimento despendido com medicamentos e insumos em razão de ter sido submetida ao procedimento cirúrgico – "Peritonectomia associada à aplicação de quimioterapia intra peritonial hipertérmica com a combinação de antineoplásticos cisplatina e mitomicina", em como indenização a título de danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. COBERTURA SECURITÁRIA - É inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente. No caso telado, postula a parte autora a condenação da demandada ao custeio das despesas do tratamento de que necessita para tratar carcinoma (medicamentos e insumos). Pugna, ainda, pela condenação da ré a lhe indenizar pelos danos morais e materiais. Assim, uma vez constatada a necessidade e efetiva utilização do medicamento em questão solicitado pelo médico que atende a parte autora (fls. 123/124), haja vista sua grave situação de saúde, sendo portadora da Doença " Pseudomixonia Periotoneal" (CID C.48.2) tenho que não há justificativa para a negativa apresentada. ***Ademais, destaca-se que o contrato prevê cobertura para a patologia que acomete a parte autora, bem como, o tratamento, negando a parte ré a cobertura tão-somente porque o medicamento em questão não está no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS. Mostra-se descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para a enfermidade e, inclusive, para o tratamento prescrito ao autor, cabendo ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento.*** *DANOS MORAIS - A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária não enseja reparação a título de dano moral. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA, POR MAIORIA E APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA, UNANIME.(Apelação Cível, Nº 70083603159, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 07-08-2020) (grifo nosso).*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RECUSA DE COBERTURA. RITUXIMABE. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO DA NEGATIVA. Trata-se de ação de cobrança, visando à condenação da ré a custear integralmente o tratamento prescrito ao autor, julgada procedente na origem. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º do CDC e da Súmula 608 do STJ. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da referida legislação. ***Descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para o tratamento prescrito ao paciente. Veja-se que não se trata de qualquer fármaco, mas de uma substância medicamentosa específica e imprescindível que faz parte do próprio tratamento realizado pela parte autora, com previsão contratual de cobertura. Ora, os tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados do medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas terapias. A busca pela cura da enfermidade do segurado, por métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve sobrepor-se a quaisquer outras considerações, pois não se pode perder de vista que o bem envolvido no contrato celebrado entre as partes é a saúde e a vida das pessoas, não podendo ser considerado com um mero negócio por parte das administradoras de planos de saúde, pelo simples argumento de que não há cobertura contratual para determinados procedimentos.*** *Ademais, o medicamento perseguido pela autora está devidamente registrado pela ANVISA sob o n. 101000548, e a necessidade do fármaco para o tratamento do autor foi devidamente atestada pelo profissional que a assistia, através do laudo acostado à fl. 66. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70082185851, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-09-2019) (sem grifo no original)*

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1793874/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019)

Ademais, na esteira do que já fundamentei, o medicamento está cadastrado na ANS para outras enfermidades e encontra-se devidamente registrado na ANVISA. Nesse sentido:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. ANTINEOPLÁSICO. AVASTIN. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA PELA MAGISTRADA A QUO, QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA FORNEÇA O TRATAMENTO COM A MEDICAÇÃO AVASTIN (BEVACIZUMABE), NO DOSE DE 10G/KG, DE USO ENDOVENOSO A CADA 15 DIAS, CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA É PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA NO ENCÉFALO. CONSOANTE RECENTES JULGADOS DO EGRÉGIO STJ, RESTOU CONSOLIDADO QUE É LÍCITA A EXCLUSÃO, NA SAÚDE SUPLEMENTAR, DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUEles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).No caso em comento, o medicamento perquirido - Avastin (bevacizumabe), foi indicado pelo médico assistente para tratamento oncológico de uso endovenoso está listado no Rol de Cobertura mínima da ANS e havendo indicação médica expressa nesse sentido, no termos do Laudo Médico (evento 1 LAUDO 4).Assim, conclui-se que devem ser cobertos, pelos planos de saúde, a medicação antineoplásica indicada para o tratamento de saúde da parte autora, eis que além de ser medicação antineoplásica, consta do rol de cobertura obrigatória da ANS - Resolução nº 465/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 52238819220218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-02-2022) - grifei*

Reitero que a operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de aplicação *off-label* (cf. REsp nº 1.721.705 - STJ).

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, a negativa de cobertura do plano contratado pela autora não se sustenta, sobretudo porque o tratamento restou devidamente prescrito por profissional capacitado para tanto, e que, ao compulsar a cenário vivenciado pela autora, constatou ser este o fármaco adequado, mostrando-se abusiva a negativa da demandada (Evento 1, EMAIL9), que limitou-se a afirmar, de forma genérica -sem fundamentação médica e técnica - que não cobriria os custos do tratamento.

Sobre o tema, mais uma vez, diz a jurisprudência:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO* ***OFF LABEL (TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE) E AVASTIN (BEVACIZUMABE). COBERTURA DEVIDA. 1. OS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 9.656/98 AO CASO EM TELA, DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL E MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES.*** *INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ.* ***2. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA O SEGURADO. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO CONTRATO PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, NÃO IMPORTANDO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ MINISTRADO (OFF LABEL).*** *3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO (VALOR DA CAUSA), NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 6º-A, DO CPC) RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50069303420218210007, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 28-09-2022) - grifei*
>
> *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA IMRT. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO. I. Preliminar. Falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo. O exaurimento das vias administrativas é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Incidência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Carta Magna de 1988. Preliminar rejeitada. II. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não vinga a alegação de cerceamento de defesa, pois fazia-se possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, do CPC. Além disso, a matéria é eminentemente de direito, inclusive, considerando as declarações do médico-assistente da paciente e o contrato firmado pelas partes de assistência à saúde. Preliminar rejeitada. III. No caso, a autora é portadora de sarcoma de partes moles operado com margem comprometida, necessitando submeter-se à realização do tratamento de Radioterapia de Intensidade Modulada de Feixe (IMRT), visando minimizar a irradiação de órgãos de risco. Contudo, não houve resposta da operadora, pelo menos em um prazo razoável, quanto à autorização do tratamento, o que motivou o ajuizamento da presente lide, com pedido de tutela de urgência. IV. Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC. V. Com efeito, o referido tratamento não está previsto nas hipóteses de exclusão do art. 10, da Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Por conseguinte, a requerida deve arcar com o tratamento indicado à parte autora. VI. Reconhecida a conduta ilícita da parte requerida e caracterizado o dano moral in re ipsa, pois, no momento da negativa de cobertura, a parte autora encontrava-se psicologicamente fragilizada em razão da doença, é cabível a indenização pretendida. Inclusive, a autora foi compelida a ajuizar a presente ação e postular a tutela de urgência, a qual foi deferida pelo juízo de origem, para ter acesso ao tratamento prescrito. Valor indenizatório arbitrado de acordo com a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios contam-se da citação, por se tratar de relação contratual. VII. Tendo sido autorizado o tratamento da autora pela Unimed Porto Alegre, pessoa jurídica distinta da requerida Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, antes mesmo desta fazer parte do feito, imperativo o afastamento da multa aplicada à demandada por descumprimento da tutela de urgência deferida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081109894, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-06-2019)*

III - Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido aforado por FATIMA TERESINHA FLORES em face de UNIMED VALE DO CAÍ/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, para os fins de CONFIRMAR a tutela de urgência concedida e, forte no art. 487, I, do CPC, CONDENAR a requerida ao fornecimento da medicação de Bevacizumabe para o tratamento do seu quadro médico, enquanto perdurar a necessidade médica, comprovada mediante apresentação de documentos atualizados, a cada seis meses.

Ante a sucumbência da ré, CONDENO-LHE ao pagamento da taxa judiciária e honorários de sucumbência ao patrono da parte adversa, no valor de R$ 800,00, por se tratar de causa de valor inestimado, pelos critérios do art. 85, § 2° e seguintes, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA ANADON CARVALHO, Juíza de Direito**, em 5/8/2023, às 23:16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10041213284v2** e o código CRC **40857586**.